



חוליה רפואית

ג'ישה אג"מית



חוליה רפואית

- הגדרה: חוליה האמונה על מתן מענה רפואי מתקדם במסגרת הפעילות המבצעית

שיט!
שכחתי את הנשק!





חשיבות החוליה

- הצורך לשלב בצורה אופטימאלית את משימת הרפואה בתוך המשימה העיקרית

- הכירות עם נקודות התורפה הרפואיות

- לפני קבלת המשימה

- אל היעד

- ביעד

- מהיעד

- במהלך פינוי

- הבנת משמעויות ותרגומן

- למפקד הכוח





קשיים מבצעיים

- יתכן כי הפצוע לא יכול להמשיך להשתתף בלחימה, ויתרה מזאת – פציעותיו מחייבות נוכחות בעל מקצוע צמוד עד יציאתו לפינוי
- רוב הטיפול יתקיים במתאר מאוים-מאובטח
- ביידות הכוח כולו נוכח פצוע שמתקשה להתנייד
- חשיפת הכוח והתבצרות





קשיים רפואיים

- מגבלות ציוד
- תנאי טיפול (שעה, נוחות, אקלים)
- איום על הכח
- סד"כ מבצעי
- רעש
- תקשורת
- פינוי
- המשימה המקורית





הכנה ואישור תכניות

- בעת הורדת הפקודה יש להעריך את מידת האיום והקשיים במשימה הנוכחית ואת הצרכים ברמת החוליה הרפואית:
 - צפי נפגעים סביר (גודל החוליה וכלי פינוי)
 - צפי פציעות וחומרה סבירות (ציוד מתוגבר)
 - צפי אקלים ותנאי סביבה נוספים (מרחק מלבנת פינוי)
 - מיקום החוליה – חבירות

In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.

Dwight D. Eisenhower



מידע המצוי בנספח רפואה לכל א.ת.

- מיקום
 - כוחות רפואה (על הקרקע ובלבנה)
 - כוחות רפואה בשחלוף (תאג"ד/טנ"צ/מד"א/מסוק)
 - נקודות שחלוף
 - יעדי פינוי ומרחק בזמן לפי כלי פינוי
 - מנחתים רלוונטיים
 - מז"א ותנאי שטח חריגים
- נעריך זמן מרגע הפציע עד הגעה
לחדר מיון.
השאיפה – פחות משעה

**הרפואה היעילה ביותר
היא רפואה מונעת**



עקרונות מנחים של חוליה רפואית

חוליה רפואית היא כוח לוחם-רפואי

- טיפול בפצוע

- מניעת פצועים נוספים

- השלמת המשימה

- מתארים של רפואה מבצעית:

- מתאר "תחת אש"

- מתאר "מאובטח-מאויים"

- מתאר "הפינוי הטאקטי"





משימת החוליה הרפואית

- סיוע במשימה האג"מית ככל שיידרש משלב ההכנות ועד סיום המשימה
- החוליה תיערך רפואית מרמת לוחם ועד מטפלים בכירים למענה רפואי שלם ל 3 פצועים דחופים לפינוי, כאשר לפחות אחד מהם זקוק להנשמה.



תפקידיו של מפקד החוליה הרפואית

- הכרת המשימה על כל פרטיה כולל נספח רפואה
- ניהול לחימה ברמת חוליה
- בניית תמונת מצב והבנת הקשיים של הצוות המטפל
- העברת מידע למפקד הכח ושמירה על תקשורת רציפה
- העברת דיווחים רפואיים וניהול טופס 101
- החברה והכוונה של כוחות חילוץ וכוחות סיוע
- העברת דרישה לאמצעי פינוי/ציוד

מי שמטפל לא מנהל
מי שמנהל לא מטפל



דגשים

- מפקד החוליה הרפואית ישאף לקבל ולהעביר לאורך כל הפעילות והטיפול את כלל המידע הנחוץ
- מפקד החוליה הרפואית הוא גורם מקשר בין כוחות רפואה לפיקוד (2 מבשירי קשר לכל פעילות)
- על הדיווחים להיות קצרים, ענייניים ומדויקים ככל הניתן
 - פצוע / הרוג
 - דחוף (לפינוי) / לא דחוף (לפינוי)
 - דחוף לטיפול (פנים חוליה)

**מיקומו של פצוע
בחדר ניתוח**



סד"פ למפקד חוליה רפואית

- הכנות לפעילות
- יציאה לפעילות ופיקוד אג"מ על החוליה
- קבלת דיווח על פצוע/פצועים, מיקומם ומצבם
- בירור דרכי הגעה לפצוע – יכולת ניווט החוליה לכל הכוח
- חבירה, הבנת תמונת מצב, טיפול בהתאם לזירה/עיבוי אבטחה במידת הצורך
- העברת דיווח ובחירת נק' ריכוז נפגעים
- קבלת מידע לגבי מועד הגעת הכוחות וצירים
- העברת דרישה לאמצעים מיוחדים
- החלטה על נקודת חבירה ואמצעי ניווט פצועים
- חבירה ללבנה/כוחות רפואה חבירים והעברת מקל
- וידוע מוכנות להמשך ביצוע משימה



מבנה החוליה



מפקד החוליה



מט"ב



חובש



לוחם





בחירת נקודת ריכוז נפגעים

- למקרה שיש צורך לאתר נקודת ריכוז נפגעים במקום לא צפוי
- להלן מספר מאפיינים חשובים נוספים:



- אבטחה ובטיחות
- קירבה לציר פינוי
- מתווה הקרקע
- תאורה
- שטח עבודה מרווח
- אפשרות ארגון פצועים לפי סדר יציאה
- אפשרות לאתר טיפול בפצועים קשים יותר



כוח עזר חובר

- כוח המגודר מראש מתוך חוליית סגירה או חוליית פריצה
- עדיפות להימצאות חובש נוסף בכוח זה
- המטרה העיקרית היא סיוע בשינוע פצועים/אבטחה
- אחרי חבירה גודל החוליה הרפואית יהיה 5-6
 - מפקד
 - מט"ב
 - 2 חובשים
 - 2 לוחמים (מחוליות שכנות או סמוכות)



מיקום החוליה בכוח

ציר מרכזי

6

3א

ח'1

פריצה

עיקרי

9א

9ב

ח'4

ב

12

ח'2

9ג

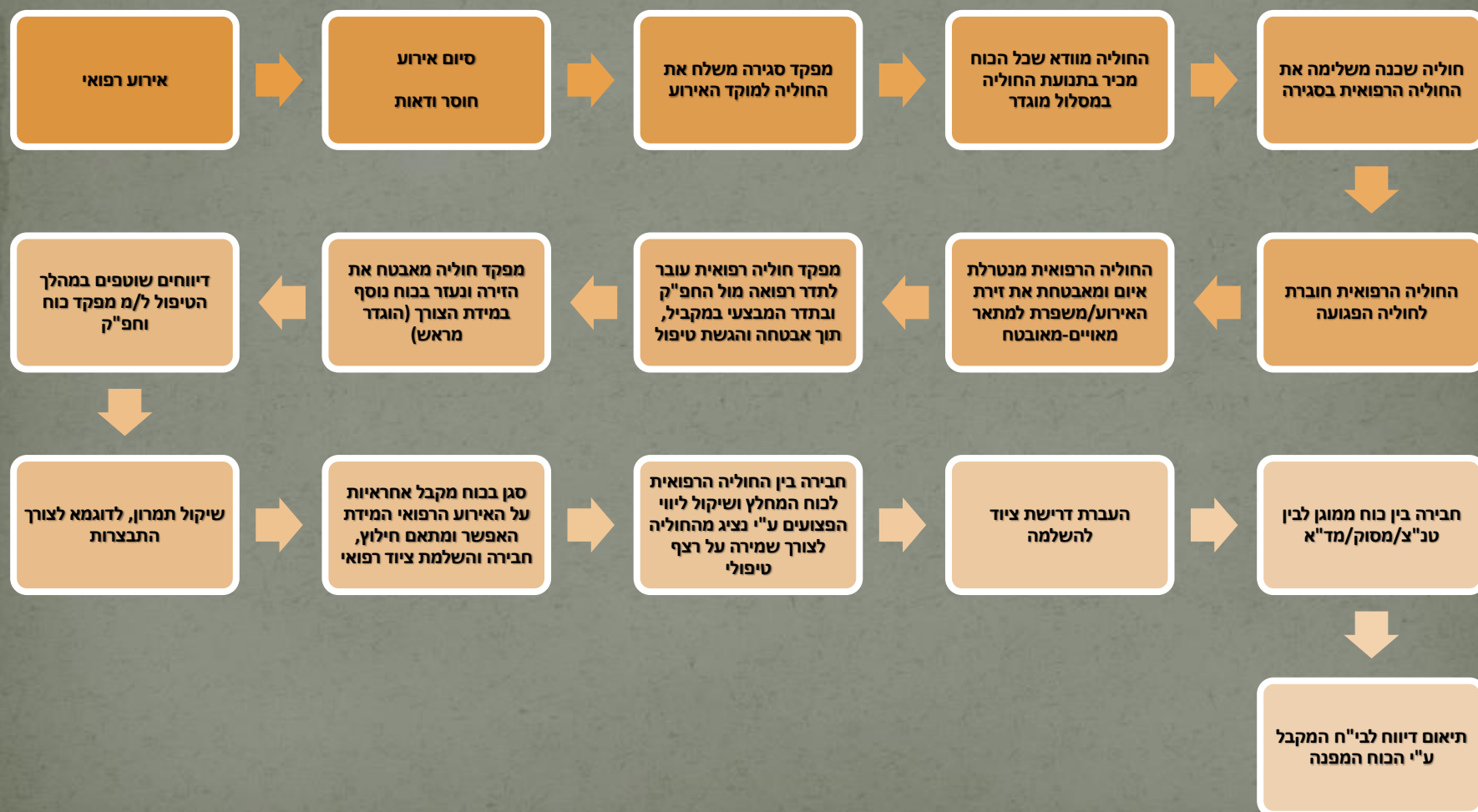
12א

ח'3

9ד



סד"פ מבצעי





תקשורת מול הצוות הרפואי

• מה מט"ב צריך?

• מי מגיע

• סוג רכב פינוי (לא בהכרח כלי שהוגדר ככלי פינוי)

• דוגמאות:

• פנתר יכול לקבל 2 שוכבים אבל עם יכולת טיפול מאוד מוגבלת

• טיגריס יכול לקבל 1 שוכב

• צוות רפואי שבכלי

• דוגמאות:

• האם הצוות שנמצא בכלי יכול לבצע את הפרוצדורה שיש לבצע בהקדם?

• האם הצוות שנמצא בכלי יכול להתמודד עם הפציעה כמו המט"ב?

• במקרה של אר"ן, האם לדעת המט"ב שימושי יותר להשמיט חלק מהצוות לטובתו?

• מתי מגיע

• זמן הגעה משואר הוא העוגן החשוב ביותר להחלטות המט"ב

• דוגמאות:

• ניהול סיכונים בין ביצוע סכמה לבין איום על הזירה

• האם להתחיל פרוצדורה שתיקח 6 דק' או לדחות אותה לפינוי



דיווח מסודר:

• דיווח ראשוני

• דיווח מאסט אחרי השלמת סכמה / טריאז'

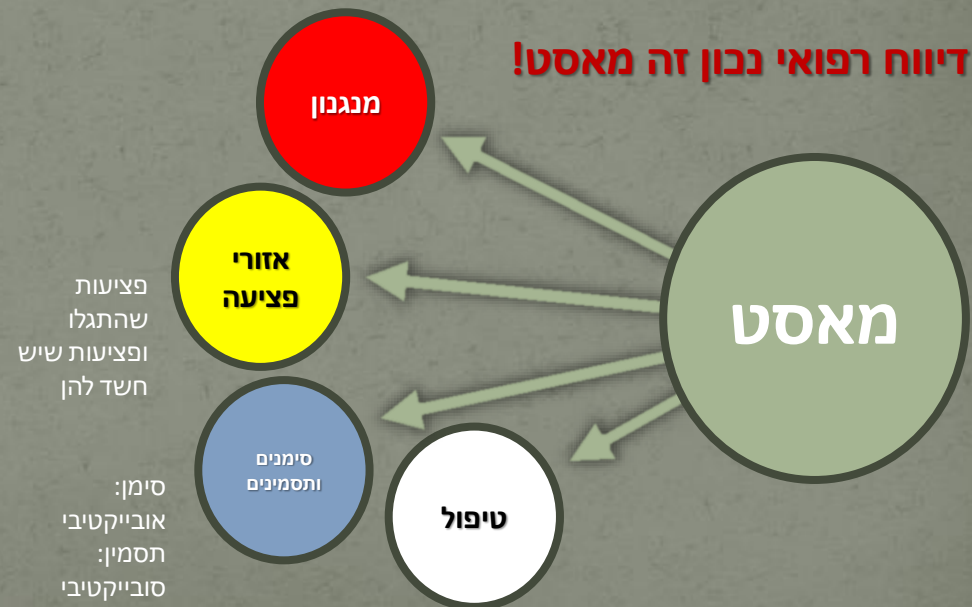
5 המ'

מקום
מה קרה
מתי קרה
מספר פצועים
מצב פצועים

תדריים זמינים למפקד חוליה רפואית:

93 - משטרת
תדר ירוק – צבאי

בצבאי, תדריים רלוונטיים:
תדר יחידה (משמש לבנה)
תדר רפואה חטיבתי (משמש הנעת
כוחות צה"ל)



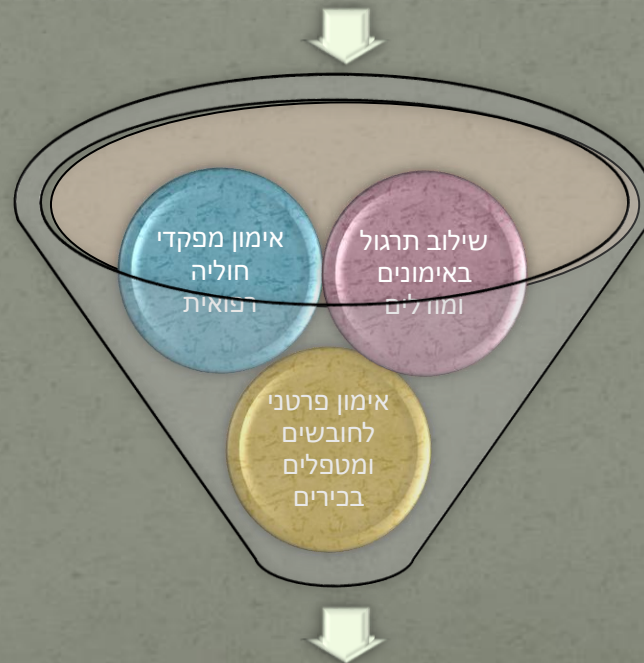
MIST :Mechanism, Injuries, Signs and Symptoms, Treatment



דגשים

- נוהל זה יופעל גם במקרה של פצוע שאינו מכוחותינו כגון אזרח או איוב מנוטרל.

שלבי הכנה לאירוע רפואי



חיי לוחמים



מושגים חיוניים למפקד חוליה רפואית

• "דחוף לטיפול"

- הפצוע עלול למות בדקות הקרובות אם לא תבוצע התערבות מצילה חיים
- לרוב, מטפל יוכל להוסיף זמן שיידרש על מנת לבצע את אותה הפעולה ולהיות מוכן לתנועה

• "דחוף לפינוי"

- הפצוע עלול למות או לסבול מנכות קשה אם לא יגיע לבית חולים, סביר להניח שיש פעולות רפואיות שניתן לבצע על מנת לשפר את סיכוייו אך ניתן לבצען במהלך פינוי

• "לא דחוף לפינוי"

- הפצוע לא צפוי למות או לסבול אם לא יגיע לבית חולים בהקדם האפשרי.
- הגדרה הכוללת גופה.
- משמעות: פגיעה ביכולת תמרון של הכוח

• "אלונקות באוויר"

- הפצוע שוכב על גבי אלונקה, קשור, ונמצא באוויר
- כוח הנושא את האלונקה וכל הכוח מכירים את מסלול התנועה
- סידור הכוח מתאים למשימה שלפניו
- העמסה על כלי – שתיים מקדימה



שאלות תרגול



שאלות לגמישות השכל הישר

- כמה פצועים שוכבים ארוך הכוח לנייד באמת? כולל אבטחה?
- כמה פצועים שוכבים אפשר להכניס לטיגריס לוחמים?
- כמה זמן לוקח להעמיס פצוע שני שוכב לטיגריס?
- מה יכולת הטיפול של המט"ב בטיגריס לוחמים?
- באיזה כלי יעלו הלוחמים שהיו אמורים לעלות בטיגריס שהוגדר ככלי פינוי?
- כיצד יש לווסת את הפצועים כאשר יש יותר מאחד?
- כמה זמן יכול מט"ב להחזיק פצוע בתרחיש התבצרות?
- כמה פצועים מונשמים יכולה להחזיק חוליה רפואית?
- כמה פלזמה מקצה צה"ל לכל מט"ב?

שאלות?

